

**QCM Infirmiers
diplômés d'état G.P.
Epreuve 2016
2ème corrigé**

SÉANCE ANIMÉ PAR :MR.HADDOUGUI
DRISS CHEF DE PSI MOHAMMEDIA

LE 01/08/2017

www.ispits.net

Q1: La performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de:

- A.** Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé
- B.** Faire un usage optimal des ressources
- C.** Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous
- D.** Mettre en place des stratégies

Q1: la performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de:

- A. Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé
- B. Faire un usage optimal des ressources
- C. Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous
- D. Mettre en place des stratégies

Q2: parmi les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé:

- A. L'importance du prépaiement,
- B. Le degré de répartition du risque financier,
- C. La qualité des services
- D. La subvention des pauvres

Q2: Parmi les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé:

- A. L'importance du prépaiement,
- B. Le degré de répartition du risque financier,
- C. La qualité des services
- D. La subvention des pauvres

4 Déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé

www.ispits.net

- ① L'importance du prépaiement,
- ② Le degré de répartition du risque financier (financement collectif),
- ③ La subvention des pauvres,
- ④ Stratégie d'achat des prestations.

Q3: les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont:

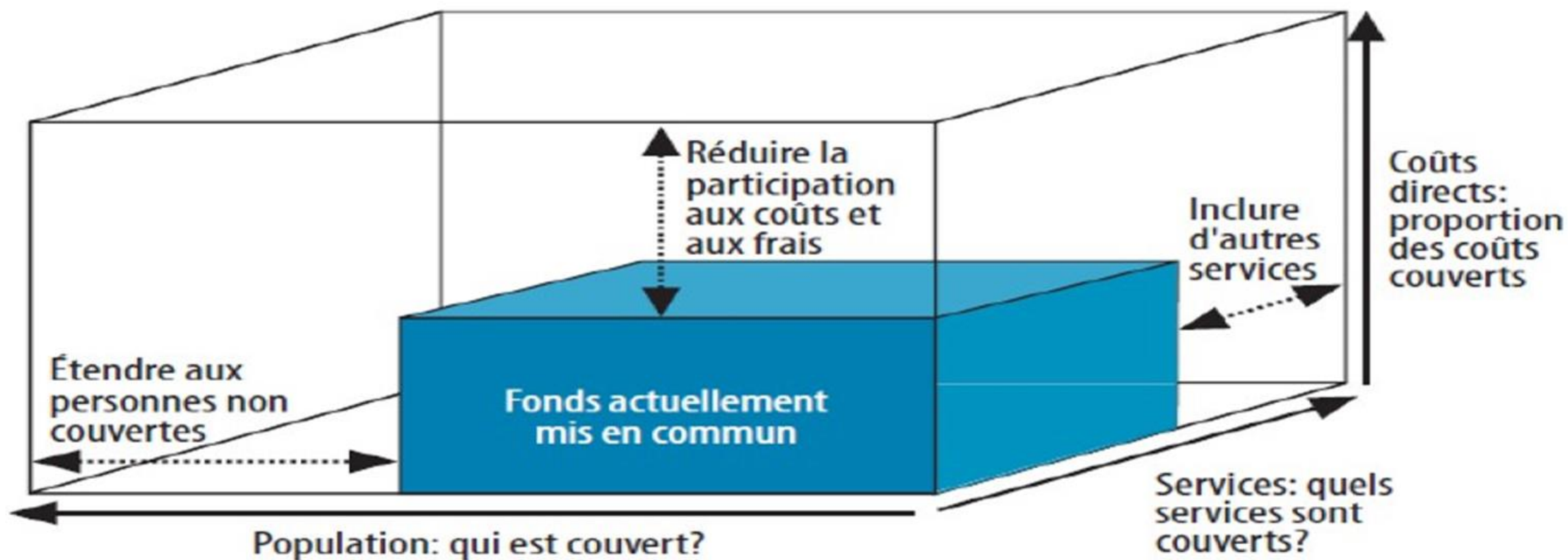
- A.** Les couts directs
- B.** La population
- C.** Les services
- D.** Les stratégies

Q3: les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont:

- A. Les couts directs
- B. La population
- C. Les services
- D. Les stratégies

DIMENSIONS

Figure 1.2. Trois dimensions à considérer lors de la progression vers une couverture universelle



**Q4: la durée moyenne de séjour DMS est
un indicateur de performance hospitalière qui
renseigne sur:**

- A.** La productivité
- B.** La qualité des soins
- C.** L'attractivité de l'hôpital
- D.** La satisfaction des clients

**Q4: la durée moyenne de séjour DMS est
un indicateur de performance hospitalière qui
renseigne sur:**

- A. La productivité**
- B. La qualité des soins**
- C. L'attractivité de l'hôpital**
- D. La satisfaction des clients**

MATRICE D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L'HOPITAL**Indicateurs de base**

FONCTIONS	A T T R I B U T S		
	PRODUCTION	EFFICACITE & QUALITE	PRODUCTIVITE
1. SOINS			
1.1.D'URGENCE	Fréquentation des urgences : • CMH/1000 hab.	Admissions urgentes : • % ADM/CMH • % ADM urgentes/ Total ADM	Utilisation des ressources : • CMH/Médecin • Examen de Rx/Médecin
1.2.D'HOSPITALISATION	Fréquentation de l'hospitalisation : • ADM/1000hab. Fréquence des hospitalisations : • Nb moyen d'ADM / Jour Fréquentation des services • ADM de MCOP/Tot. ADM	Accès à l'hôpital : • Délai RDV D'hospitalisation Mortalité à l'hôpital : • Tx de mortalité intrahosp (%) • TMM intra-hospitalière	• DMS • NB d'interventions majeures/chirurgien
1.3.DE CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES EXT.	Fréquentation des CSE : Nb de CSE / 1000 hab	Délai de RDV pour CSE (en j) % des ADM par CSE / Total ADM	CSE/MED Spécialiste
2. DIAGNOSTIC			
2.1. IMAGERIE	NB d'examens d'imagerie/1000 Hab.	% D'examens d'imagerie positifs % Films défectueux	Nb de Z/CMH+CSE NB Z/Techniciens de RADIO
2.2. LABORATOIRE	Nb d'examens de labo/1000 Hab.		NB B/ CMH+CSE NB B/Techniciens de Labo
3. HOTELLERIE			
3.1. SEJOURS	JH/POP(JH/1000 Hab)	TROT	TOM
3.2. RESTAURATION			
4. FINANCE			
4.1. FACTURATION	Factures émises /ADM	Factures émises pour indigents/ADM indigentes	Tx de recouvrement
4.2. RECETTES PROPRES	Volume des recettes/ jour	% Recettes propres/Budget Hosp.	Recettes propres/ADM

Q5: Parmi les objectifs de l'économie de la santé:

- A. Réduire les dépenses en santé,
- B. Contrôler les agents économiques,
- C. Rechercher la meilleure utilisation des ressources
- D. Proposer des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.

www.ispits.net

Q5: Parmi les objectifs de l'économie de la santé:

- A. Réduire les dépenses en santé,
- B. Contrôler les agents économiques,
- C. Rechercher la meilleure utilisation des ressources
- D. Proposer des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.

Economie de la santé: objectif

⊕ L'objectif de l'économie de la santé:

— ⊞ Faire des économies.

— ⊞ Diminuer les dépenses.

— ⊞ Contrôler les agents économiques.

⊞ **Rechercher la meilleure utilisation des ressources.**

↪ Evaluation en terme de **coûts** et d'**efficience** de la production de soins et de services médicaux alloués à une population et surtout **la proposition des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.**

Q6: le cout peut se définir en étant:

- A. L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service en plus de l'usure des immobilisations nécessaires à cette production,
- B. L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service pendant un moment,
- C. Résultante de la confrontation de deux forces contraires l'offre et la demande en plus de l'obsolescence des immobilisations des deux forces
- D. Prix fixé par l'institution pour un produit pour des raisons économiques et sociales.

Q6: le cout peut se définir en étant:

- A. L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service en plus de l'usure des immobilisations nécessaires à cette production,
- B. L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service pendant un moment,
- C. Résultante de la confrontation de deux forces contraires l'offre et la demande en plus de l'obsolescence des immobilisations des deux forces
- D. Prix fixé par l'institution pour un produit pour des raisons économiques et sociales.

CONCEPTS

www.ispits.net

- ❖ **Coût:** c'est l'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service, ainsi que l'usure ou l'obsolescence (amortissement) des immobilisations nécessaires à cette production.
- ❖ **Prix:** résultante de la confrontation de deux forces contraires offre/ demande.
- ❖ **Tarif:** prix fixé institutionnellement par une autorité pour des raisons économiques ou sociales

Q7: les comptes nationaux de la santé:

- A. Incluent toutes les parties jouant un rôle dans le financement
- B. Approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national
- C. fournissent des estimations approximatives
- D. Ils sont axés autour des sources de financement

Q7: les comptes nationaux de la santé:

- A. Incluent toutes les parties jouant un rôle dans le financement
- B. Approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national
- C. fournissent des estimations approximatives
- D. Ils sont axés autour des sources de financement

La classification internationale des CNS

21

👉 Un système de classification complet axé autour de 4 éléments principaux:

1. **Les sources de financement**: contribution des différents intervenants.
2. **Les agents de financement**: entités chargées de gérer les dépenses de santé.
3. **Les prestataires**: entités qui fournissent les B&S en rapport avec les services de santé.
4. **Les fonctions**: types de B&S fournis et d'activités de soins assurées par le système de santé.

Autres avantages des comptes nationaux de santé

-  Ils incluent **toutes les parties jouant un rôle dans le financement** : Publiques, semi-publiques et privées.
-  Ils fournissent une **norme internationale** qui permet aux décideurs de **faire des comparaisons** dans le temps et avec les autres pays.
-  Ils sont **facilement compris par les décideurs**, y compris ceux n'ayant pas de formation en économie.
-  Ils fournissent des **estimations plus précises** au lieu des estimations approximatives faites par les organisations internationales ou les bailleurs de fonds internationaux.

Q8: parmi les dimensions de la qualité en santé:

- A. L'innocuité des soins
- B. La performance du système
- C. L'accessibilité aux soins
- D. La réactivité et l'empathie

Q8: parmi les dimensions de la qualité en santé:

A. L'innocuité des soins

B. La performance du système

C. L'accessibilité aux soins

D. La réactivité et l'empathie

Les 8 dimensions de la qualité en sante

1. La compétence humaine ou compétence professionnelle des soins:
2. **L'accessibilité aux soins** : Barrières (géographique, financière , sociale , culturelle, linguistiques)
3. L'efficacité des soins (méthodes/milieu Résultats)
4. La continuité des soins (soins complets sans interruption, suivi)
5. L'efficience des services de santé (Soin Optima //Non maxima)
6. Les relations interpersonnelles (marque de respect, de confidentialité , de courtoisie , **d'empathie et de réactivité** ...)
7. **L'innocuité des soins /Sécurité**
8. Les agréments des services de santé

Q9: parmi les approches de résolution des problèmes pour l'amélioration de la qualité:

- A. Résolution individuelle de problème
www.ispits.net
- B. Résolution systématique de problème en équipe
- C. Résolution institutionnelle de problème
- D. Amélioration des processus

Q9: parmi les approches de résolution des problèmes pour l'amélioration de la qualité:

- A. Résolution individuelle de problème
- B. Résolution systématique de problème en équipe
- C. Résolution institutionnelle de problème
- D. Amélioration des processus

Q10: l'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité doit:

- A.** La source d'information sur le problème
- B.** Évoquer la fréquence du problème
- C.** Indiquer la solution du problème
- D.** Mentionner la cause du problème.

Q10: l'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité doit:

- A. La source d'information sur le problème**
- B. Évoquer la fréquence du problème**
- C. Indiquer la solution du problème**
- D. Mentionner la cause du problème.**

Q11: les catégories des déterminants de la santé:

- A. Mode de vie
- B. Environnement
- C. Organisation des soins
- D. Technologie médicale

Q11: les catégories des déterminants de la santé:

A. Mode de vie

B. Environnement

C. Organisation des soins

D. Technologie médicale

Q12: l'intégration des soins est:

- A. Une intégration dans le temps et dans l'espace
- B. Une intégration dans le temps et dans l'espace et des services
- C. Une intégration dans l'espace et des services
- D. Une intégration dans le temps et des services

Q12: l'intégration des soins est:

- A. Une intégration dans le temps et dans l'espace
- B. Une intégration dans le temps et dans l'espace et des services
- C. Une intégration dans l'espace et des services
- D. Une intégration dans le temps et des services

Q13: les études épidémiologiques sont classées selon:

- A. L'élément de départ
- B. Le temps
- C. L'objectif de l'étude
- D. Les moyens d'investigation

Q13: les études épidémiologiques sont classées selon:

- A. L'élément de départ
- B. Le temps
- C. L'objectif de l'étude
- D. Les moyens d'investigation

www.ispits.net

Q14: une étude transversale est une étude épidémiologique

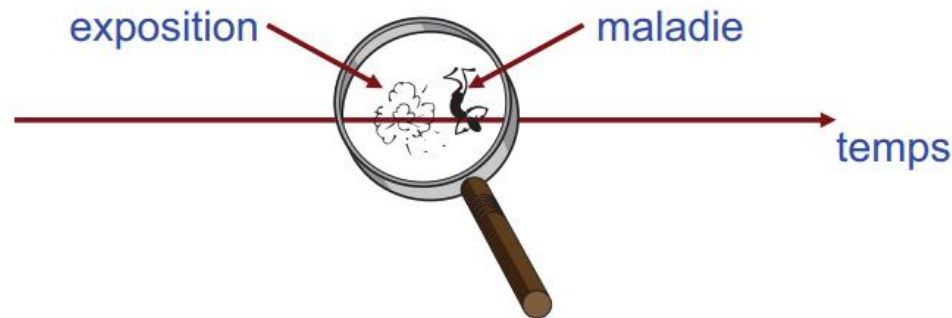
- A. De prévalence
- B. S'intéresse aux conditions passées du groupe étudié
- C. Prospective
- D. Donne des informations généralisables

Q14: une étude transversale est une étude épidémiologique

- A. De prévalence
- B. S'intéresse aux conditions passées du groupe étudié
- C. Prospective
- D. Donne des informations généralisables

Etude transversale

- ▶ Mesures simultanées de l'exposition et de la maladie dans une population donnée, à un instant unique
 - **étude transversale = études de prévalence**
 - ▶ Un seul examen de la population
 - ▶ Mesure la prévalence et donne un image instantané de la situation sanitaire
 - ▶ Mais méconnaît les variations dans le temps et sous estime les phénomènes aigus



Q15: un rapport où le numérateur est compris dans le dénominateur pendant un temps donné est:

- A. Indice**
- B. Ratio**
- C. Taux**
- D. Proportion**

Q15: un rapport où le numérateur est compris dans le dénominateur pendant un temps donné est:

- A. Indice
- B. Ratio
- C. Taux
- D. Proportion

LES INDICATEURS EN SANTE

Rappel sur les outils de mesure :

■ ***Proportion...***

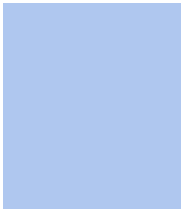
www.ispits.net

■ ***Ratio...***

■ ***Taux...***

■ ***Indice...***

... tous des **rapports!**



PROPORTION

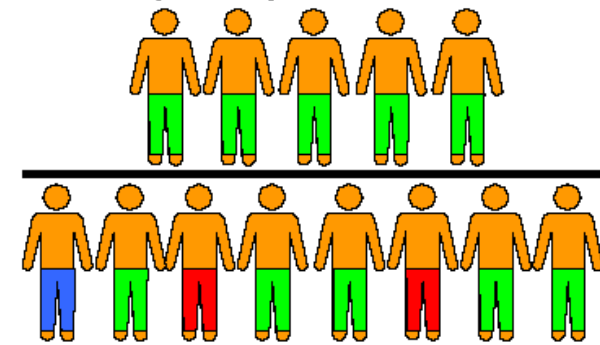
Rapport des effectifs d'une même variable (numérateur est compris dans le dénominateur)

- $P = a / (a+b)$

C'est une mesure statique

- S'exprime en % ou en chiffre de $0 \rightarrow 1$

Il s'agit d'un rapport exprimant la fréquence relative, dans l'échantillon, des sujets présentant une caractéristique donnée.



Ex : sur 7500 enfants de <5 ans, 5300 sont correctement vaccinés contre la rougeole :

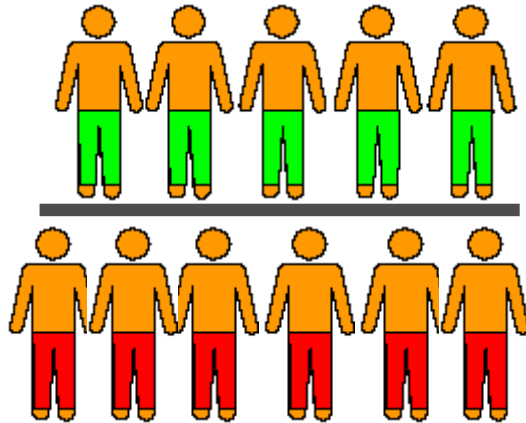
$$5300/7500 = \text{couverture vaccinale de la rougeole} = 0,70666 = 70,66 \%$$



RATIO

Rapport des effectifs des 2 modalités d'une même variable (numérateur et dénominateur sont mutuellement exclusifs)

- Variable sexe à 2 modalités (F, H) : *sex ratio* = H/F
- Pas d'unité



Ex: sur 100 individus, 49 hommes et 51 femmes

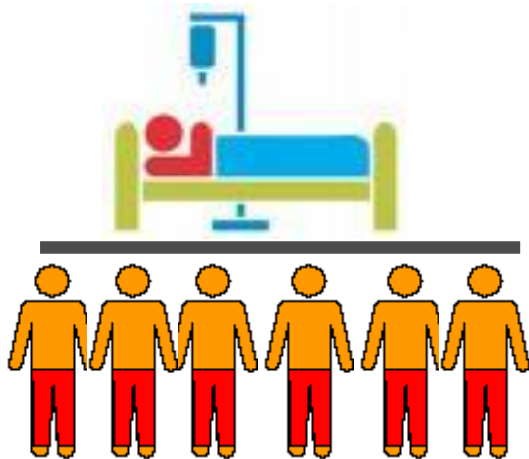
⇒ Sex ratio = 0,96 (0,96 hommes pour 1 femme)



Rapport des effectifs de deux variables différentes

- Économie de la santé

Indice lit-population = Nombre de lits dans les structures hospitalières / taille de la population



Ex: à l'hôpital pédiatrique, 1000 enfants pour 10 infirmières soit $1000/10 = 100$ enfants par infirmière

TAUX

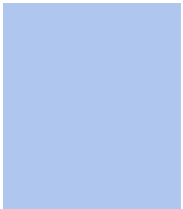
C'est une proportion mais inclue une notion de temps : Rapport des effectifs d'une même variable (numérateur est compris dans le dénominateur)

- Notion de temps : mesure la vitesse d'apparition d'un événement au cours du temps, pour un groupe d'individus donné, en un lieu donné.

$$\text{Taux} = \frac{\text{nombre d'événements nouveaux}}{\text{total d'événements possibles} \times dt}$$

C'est une mesure dynamique

- S'exprime en chiffre de 0 → 1, en %, ‰, ‱, ‰‰



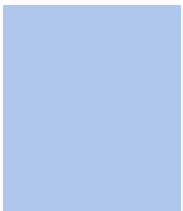
TAUX

- Notion de risque : Risque = probabilité

Taux = probabilité de survenue d'un évènement au cours d'une période

$$\text{Taux} = \frac{\text{Nombre de "changements" d'états pendant une durée T}}{\text{Nombre de sujet à risque de changement d'état pendant cette durée T}}$$

- *Ex: Taux de mortalité, taux de létalité*



Q16: les fonctions d'un système de santé:

- A. Prestation de services
- B. Financement
- C. Gouvernance
- D. Évaluation

Q16: les fonctions d'un système de santé:

- A. Prestation de serviceswww.ispits.net
- B. Financement
- C. Gouvernance
- D. Évaluation

Q17: la prévalence est le nombre de:

- A. Nouveau cas survenus dans une population à risque pendant un intervalle de temps
- B. Nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné
- C. Taux de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée
- D. Nombre de cas existant dans une population donnée.

Q17: la prévalence est le nombre de:

- A. Nouveau cas survenus dans une population à risque pendant un intervalle de temps
- B. Nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné
- C. Taux de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée
- D. Nombre de cas existant dans une population donnée.

Q18: le taux de létalité est:

- A. Le nombre de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique
- B. Proportion de décès dans une population pendant une période définie
- C. Proportion de décès pour sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée
- D. Nombre de décès pour cause donnée pendant une période donnée.

Q18: le taux de létalité est:

- A. Le nombre de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique
- B. Proportion de décès dans une population pendant une période définie
- C. Proportion de décès pour sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée
- D. Nombre de décès pour cause donnée pendant une période donnée.

Q19: parmi les domaines d'action prioritaires qui contribuent à réaliser l'objectif de l'OMS relatif au « vieillissement en bonne santé »:

- A.** Harmoniser les systèmes de santé aux besoins de la population
- B.** Développer les systèmes de soins spécifiques
- C.** Créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées ;
- D.** Améliorer l'évaluation, les méthodes de surveillance et la compréhension

Q19: parmi les domaines d'action prioritaires qui contribuent à réaliser l'objectif de l'OMS relatif au « vieillissement en bonne santé »:

- A. Harmoniser les systèmes de santé aux besoins de la population
- B. Développer les systèmes de soins spécifiques
- C. Créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées ;
- D. Améliorer l'évaluation, les méthodes de surveillance et la compréhension

Un cadre de santé publique relatif au *Vieillissement en bonne santé*

La nécessité d'élaborer une action globale de santé publique relative aux personnes âgées constitue une urgence. Bien qu'il existe de grandes lacunes en matière de connaissances à ce sujet, nous disposons cependant de suffisamment de données probantes pour agir dès maintenant, et chaque pays peut faire quelque chose, indépendamment de sa situation actuelle ou de son niveau de développement.

De nombreuses portes d'entrée peuvent être identifiées pour les mesures visant à favoriser un *Vieillissement en bonne santé*, mais toutes auront un seul but : optimiser les capacités fonctionnelles. Ceci peut être réalisé de deux façons : en renforçant et en entretenant les capacités intrinsèques, et en permettant à une personne présentant une limitation des capacités fonctionnelles de réaliser les activités qui sont importantes pour elle.

Les principales opportunités pour prendre des mesures optimisant les capacités fonctionnelles et les capacités intrinsèques tout au long de la vie, sont présentées sur la [figure 2](#). Le schéma identifie trois sous-populations différentes de personnes âgées : celles avec des capacités relativement élevées et stables, celles avec une diminution des capacités et celles avec des limitations fonctionnelles significatives. Ces sous-groupes ne sont pas figés et ils ne couvrent pas non plus le parcours de vie de chaque personne âgée. Toutefois, si on répond aux besoins de ces sous-groupes, la plupart des personnes âgées verront une amélioration de leurs capacités fonctionnelles. Quatre domaines d'action prioritaires peuvent contribuer à réaliser cet objectif :

1. harmoniser les systèmes de santé aux besoins des personnes âgées auxquelles ils s'adressent à présent ;
2. développer des systèmes de soins de longue durée ;
3. créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées ;
4. améliorer l'évaluation, les méthodes de surveillance et la compréhension de ce sujet.



**Organisation
mondiale de la Santé**

Rapport mondial sur le vieillissement
et la santé

© Organisation mondiale de la Santé, 2015

www.ispits.net

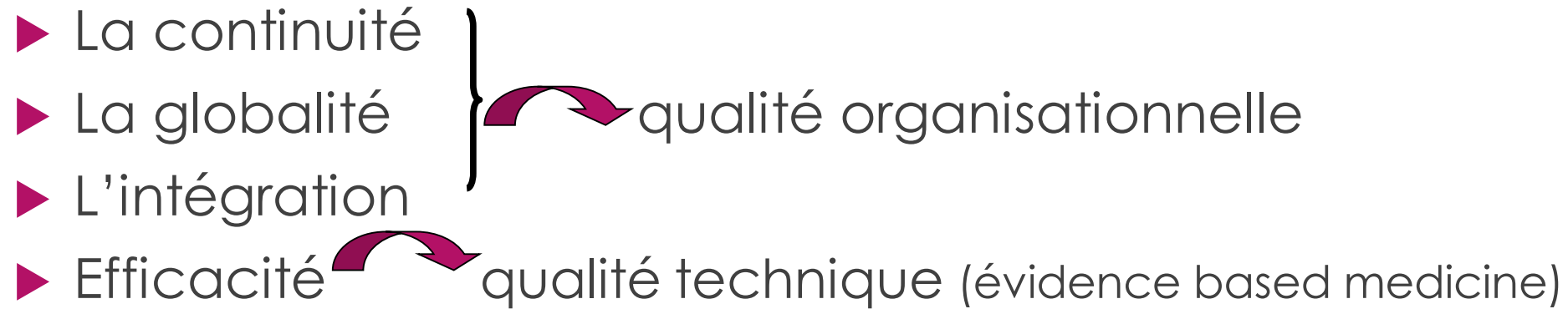
Q20: un soins efficace se caractérise par:

- A. Continuité
- B. Intégration
- C. Globalité
- D. Efficience

Q20: un soins efficace se caractérise par:

- A. Continuité
- B. Intégration
- C. Globalité
- D. Effcience ?

Caractéristiques des soins



Condition:

- ▶ Une bonne communication professionnelle de santé/population
- qualité relationnelle

SOINS EFFICACES

- Faire les *choses bien* mais aussi faire les *bonnes choses*!
 - Faire les *choses bien* = efficacité
 - faire les *bonnes choses* = efficience
- Efficacité opérationnelle = Continuité ,Globalité, Intégration (CGI)
- Efficacité technique: Médecine basée sur la preuve scientifique (Evidence-Based Medicine)

Q21: les caractéristiques d'un service de soins sont:

- A. Décentralisation, permanence, polyvalence
- B. Décentralisation, efficience, accessibilité
- C. Spécificité, efficacité, permanence
- D. Décentralisation, polyvalence, proximité

Q21: les caractéristiques d'un service de soins sont:

- A. Décentralisation, permanence, polyvalence
- B. Décentralisation, ^{www.ispits.net} efficience, accessibilité
- C. Spécificité, efficacité, permanence
- D. Décentralisation, polyvalence, proximité

Q22: l'évaluation des politiques en santé publique vise à:

- A. Apporter des solutions
- B. Juger du succès ou de l'échec d'une action
- C. Aider à la solution
- D. Améliorer l'ensemble du processus de planification

Q22: l'évaluation des politiques en santé publique vise à:

- A. Apporter des solutions
- B. Juger du succès ou de l'échec d'une action
- C. Aider à la solution
- D. Améliorer l'ensemble du processus de planification

Q23: l'efficacité exprime:

- A. Le rapport des résultats d'un programme ou d'une action de santé aux moyens engagés
- B. L'effet désiré d'un programme ou d'une action de santé sur la réduction d'un problème de santé
- C. Le degré de réalisation des objectifs et cibles prédéterminées d'un programme
- D. L'effet global d'un programme ou d'une action de santé sur le développement sanitaire

Q23: l'efficacité exprime:

- A. Le rapport des résultats d'un programme ou d'une action de santé aux moyens engagés
- B. L'effet désiré d'un programme ou d'une action de santé sur la réduction d'un problème de santé
- C. Le degré de réalisation des objectifs et cibles prédéterminées d'un programme
- D. L'effet global d'un programme ou d'une action de santé sur le développement sanitaire

Q24: parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé ,on trouve:

- A.** Disponibilité
- B.** Taux d'accroissement
- C.** Utilisation des services
- D.** Taux de recouvrement

Q24: parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé ,on trouve:

- A. Disponibilité
- B. Taux d'accroissement
- C. Utilisation des services
- D. Taux de recouvrement

Q25: parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve:

- A. Taux de mortalité maternelle
- B. Disponibilité des médicaments essentiels
- C. Taux d'accouchement en milieu surveillé
- D. Espérance de vie à la naissance

Q25: parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve:

- A. Taux de mortalité maternelle
- B. Disponibilité des médicaments essentiels
- C. Taux d'accouchement en milieu surveillé
- D. Espérance de vie à la naissance

Q26: la santé communautaire:

- A. Fait partie intégrante de la santé publique
- B. Peut être populationnelle et individuelle
- C. Est liées à un ensemble de facteurs démographiques, géographiques, sociaux
- D. Est fondée sur le principe de « faire pour » les gens

Q26: la santé communautaire:

- A. Fait partie intégrante de la santé publique
- B. Peut être populationnelle et individuelle
- C. Est liées à un ensemble de facteurs démographiques, géographiques, sociaux
- D. Est fondée sur le principe de « faire pour » les gens

Le concept de santé communautaire

- La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d'être populationnelle et non individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs grands principes :
 - ✓ la santé est liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux, économiques...) qui ne touche pas qu'un individu mais toute une population, i.e. une communauté ; ces facteurs sont répartis de manière inégale entre les territoires ;
 - ✓ la médecine, le système de soins et les politiques publiques n'apportent pas toujours une approche assez globale de la santé ;
 - ✓ les comportements individuels sont difficiles à faire changer ; l'implication des « gens » est fondamentale pour parvenir à un changement ; il ne s'agit pas de « faire pour » les gens, mais « avec » eux.
- Réf. Fiche 5 : La participation à l'évaluation des politiques publiques de santé

Q27: les acteurs impliqués dans le diagnostic communautaire sont:

- A.** La population/communauté
- B.** Les agents de développement/médiateurs
- C.** Les professionnels et les experts
- D.** L'individu

Q27: les acteurs impliqués dans le diagnostic communautaire sont:

- A. La population/communauté
- B. Les agents de développement/médiateurs
- C. Les professionnels et les experts
- D. L'individu

Les acteurs impliqués se positionnent ainsi:

- **la population / la communauté** : il s'agit d'un ensemble d'habitants, d'un groupe, de personnes travaillant dans les mêmes locaux ou vivant dans un même immeuble...
- **les agents de développement / les médiateurs** : ils peuvent impulser des projets, faire le lien entre population et administration, faciliter les démarches... ; ils aident à l'autonomisation du groupe ;
- **les professionnels et les experts** : ils sont associés à la réflexion, mais leur expertise est une contribution et non une solution unique ;
- **les décideurs et élus** : leurs choix et leur soutien à la santé communautaire est un élément déterminant de son implantation et de son développement.
- **Réf: Fiche 5** : La participation à l'évaluation des politiques publiques de santé

Q28: les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé:

- A.** La disponibilité des ressources suffisantes
- B.** L'utilisation efficiente et équitable des ressources
- C.** La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins
- D.** La gouvernance du système national de santé

Q28: les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé:

- A. La disponibilité des ressources suffisantes
- B. L'utilisation efficiente et équitable des ressources
- C. La dépendance excessives aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins
- D. La gouvernance du système national de santé

Faisant partie des États membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Maroc s'est engagé également en 2005 à développer son système de financement de la santé afin que tout un chacun puisse accéder aux services, sans subir de difficultés financières lors de leur paiement. Cet objectif a été défini comme la couverture universelle, parfois appelée la «couverture universelle de santé». Pour progresser vers cet objectif, le gouvernement marocain est en train de faire face à trois problèmes essentiels :

- 1. La disponibilité des ressources suffisantes ;**
- 2. La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins ;**
- 3. L'utilisation efficiente et équitable des ressources.**

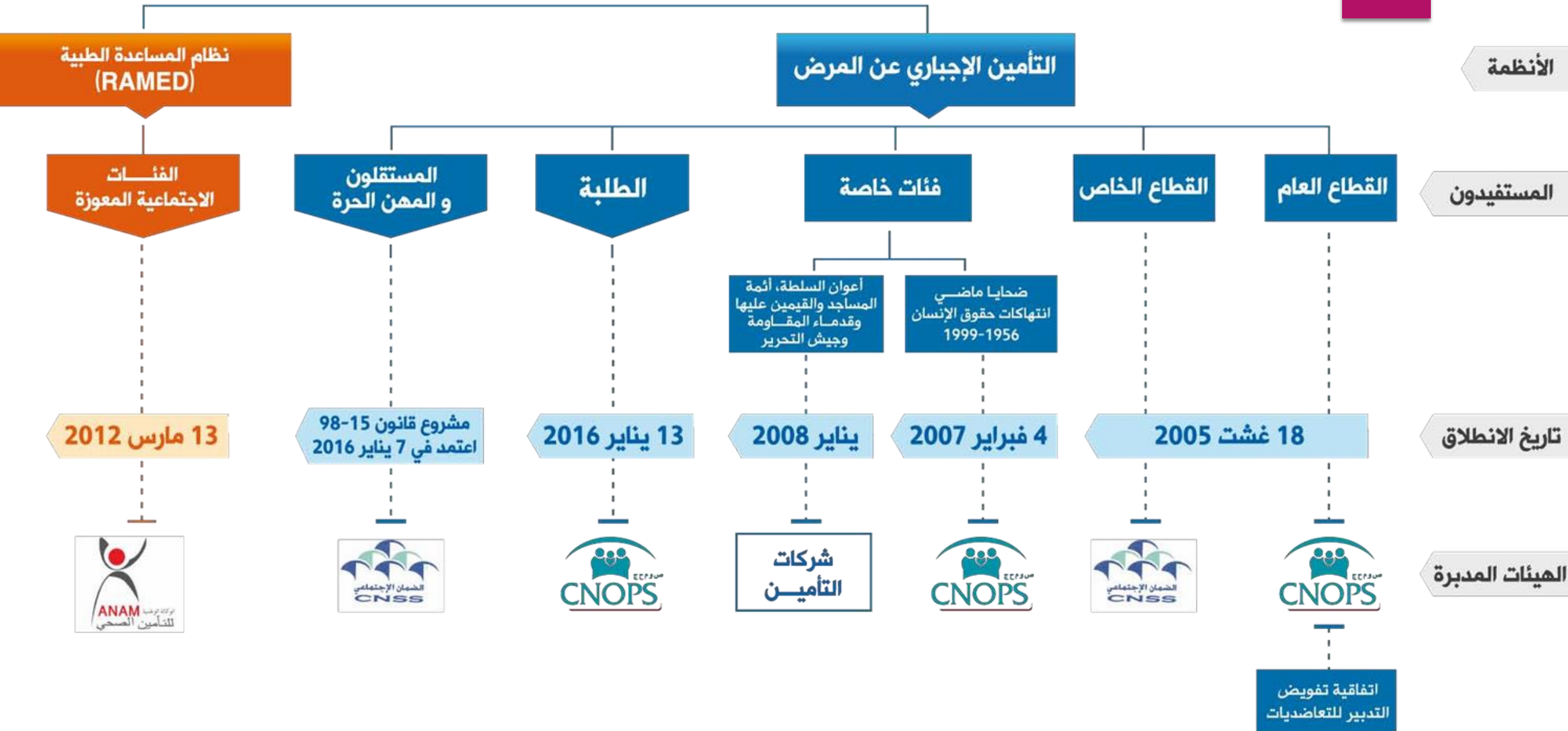
Q29: la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale gère l'AMO pour:

- A.** Les étudiants
- B.** Les anciens victimes des violations des droits de l'homme
- C.** Les anciens membres de la résistance
- D.** Les agents de l'autorité et les Imams des mosquées

Q29: la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale gère l'AMO pour:

- A. Les étudiants
- B. Les anciens victimes des violations des droits de l'homme
- C. Les anciens membres de la résistance
- D. Les agents de l'autorité et les Imams des mosquées

القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية



التأمين الإجباري
عن المرض الخاص بالطلبة

288 ألف شخص (توقعات)

القانون 116-12



القانون 65-00
تفويض التدبير

OMFAM
MGEN
MFA
M. Police
MGPAP
M. Douanes
MGPTT
MODEP

أكثر من 3 ملايين شخص

القانون 120-13

مستخدمو المكتب
الوطني للسكك الحديدية

62 ألف شخص

التدبير لفائدة الدولة

ضحايا ماضي انتهاكات
حقوق الإنسان 1956-1999

17 ألف شخص

Q30: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées , par ordre décroissant, pour:

- A.** Achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers, soins ambulatoires
- B.** Achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires , soins hospitaliers
- C.** soins hospitaliers, achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires
- D.** soins ambulatoires , achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers,

Q30: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées , par ordre décroissant, pour:

- A. Achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers, soins ambulatoires
- B. Achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires , soins hospitaliers
- C. soins hospitaliers, achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires
- D. soins ambulatoires , achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers,

Classification Fonctionnelle des Dépenses des Prestataires

Structure des Dépenses par type de Prestation

85

○ Soins hospitaliers:	25,40%
○ Soins Ambulatoires :	29,40 %
○ <u>Médicaments et biens médicaux:</u>	<u>31,70%</u>
○ Administration:	7.40%
○ Prévention Sanitaire Collective:	2.10 %
○ Formation Enseignement Recherche:	1.10%
○ Autres prestations:	2.90%

Les Ressources mobilisées sont consacrées pour une grande partie aux médicaments.

Q31: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses des ménages, ont été consacrées, par ordre décroissant, pour les prestations suivantes:

- A.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, consultations médicales, hospitalisation, analyses médicales
- B.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, , analyses médicales , consultations médicales
- C.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, consultations médicales, analyses médicales
- D.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux , analyses médicales, hospitalisation, consultations médicales

Q31: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses des ménages, ont été consacrées, par ordre décroissant, pour les prestations suivantes:

- A.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, consultations médicales, hospitalisation, analyses médicales
- B.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, , analyses médicales , consultations médicales
- C.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, consultations médicales, analyses médicales
- D.** Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux , analyses médicales, hospitalisation, consultations médicales

Structure des Dépense des Ménages par type de Prestation

○ <u>Pharmacie et FBM:</u>	<u>50,00%</u>
○ Hospitalisations:	15,90 %
○ Consultations médicales et paramédicales:	12,50%
○ Analyses médicales et examens radiologiques:	10,90%
○ Soins dentaires:	5,60%
○ Médecine traditionnelle:	5.20%

Les Dépenses en Médicaments et Biens Médicaux accaparent la moitié des DDM, cela s'explique par le recours de plus en plus de la population à l'automédication qui s'explique par la faiblesse de la Couverture Médicale.

Q32: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses de la coopération internationale ont été orientées essentiellement vers

- A. L'équipement**
- B. L'investissement**
- C. L'expertise**
- D. Médicaments et biens médicaux.**

Q32: selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses de la coopération internationale ont été orientées essentiellement vers

- A. L'équipement
- B. L'investissement
- C. L'expertise
- D. Médicaments et biens médicaux.

Q33: les trois causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonataux survenus les 48 premiers heures de la vie sont:

- A.** Les anomalies liées à une brièveté de la gestation
- B.** L'hypoxie intra-utérine
- C.** Le diabète gestationnel
- D.** Les infections spécifiques de la période périnatale

Q33: les trois causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonataux survenus les 48 premiers heures de la vie sont:

- A. Les anomalies liées à une brièveté de la gestation
- B. L'hypoxie intra-utérine
- C. Le diabète gestationnel
- D. Les infections spécifiques de la période périnatale

Q34: le plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021 comprend:

- A.** 4 axes et 17 mesures
- B.** 5 axes et 21 mesures
- C.** 6 axes et 20 mesures
- D.** 7 axes et 23 mesures

Q34: le plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021 comprend:

- A. 4 axes et 17 mesures
- B. 5 axes et 21 mesures
- C. 6 axes et 20 mesures
- D. 7 axes et 23 mesures

Q35: parmi les axes du plan d'action national sur la santé et le handicap 2015- 2021 on trouve:

- A.** Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat
- B.** La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation
- C.** Le renforcement de la participation communautaire
- D.** La recherche

Q35: parmi les axes du plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021 on trouve:

- A. Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat
- B. La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation
- C. Le renforcement de la participation communautaire
- D. La recherche



PRINCIPES

- ◆ Respect de la dignité
- ◆ Non-discrimination
- ◆ Participation
- ◆ Égalité des chances
- ◆ Accessibilité

OBJECTIF GÉNÉRAL

Assurer l'accès des personnes en situation du Handicap à des services de santé promotionnels, préventifs, de prise en charge et de réadaptation, de proximité et de qualité basés sur l'approche droit.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- ◆ 1 Éliminer les obstacles et améliorer l'accès aux services de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du Handicap ;
- ◆ 2 Assurer une prise en charge de qualité des besoins spécifiques des Personnes en Situation du Handicap ;
- ◆ 3 Renforcer et développer les services d'aide technique, de soutien, et de réadaptation à base communautaire ;
- ◆ 4 Mobiliser et impliquer les partenaires institutionnels et communautaires en vue d'assurer une réponse globale et intégrée aux besoins des Personnes en Situation du Handicap ;
- ◆ 5 Intégrer la dimension du Handicap dans le Système National d'Information Sanitaire ;
- ◆ 6 Développer et soutenir la recherche scientifique dans le domaine du Handicap.

AXES STRATÉGIQUES

Axe 1

Renforcement des programmes et des actions de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du Handicap

Objectif : Contribuer à la réduction de la prévalence du Handicap.

Mesure 1 : Consolider les programmes de santé qui contribuent à la prévention du Handicap ;

Mesure 2 : Réduire les complications des maladies chroniques ;

Mesure 3 : Développer des programmes de dépistage précoce des pathologies à l'origine du Handicap ;

Mesure 4 : Promouvoir des espaces supportifs et des environnements sains ;

Mesure 5 : Prévenir l'émergence des maladies mentales ;

Mesure 6 : Mettre en place des actions de lutte contre les facteurs de risque.

Axe 2

Amélioration de la prise en charge des besoins des personnes en situation du Handicap

Objectif : Assurer la disponibilité d'une prise en charge de qualité adaptée aux besoins des personnes en situation du Handicap y compris les soins de réadaptation.

Mesure 7 : Développer les structures de prise en charge du Handicap moteur ;

Mesure 8 : Améliorer l'accessibilité financière à la prise en charge des personnes en situation du Handicap ;

Mesure 9 : Développer des structures de prise en charge de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent ;

Mesure 10 : Assurer la prise en charge des personnes atteintes de troubles auditifs, oculaires, dyslexiques et de comportements.

Axe 3

Renforcement de la formation de base et la formation continue

Objectif : Assurer la disponibilité en ressources humaines spécialisées et compétentes ;

Mesure 11 : Réviser et adapter les cursus de formation de base du personnel médical, infirmier et technicien spécialisé ;

Mesure 12 : Créer de nouvelles filières et spécialités dans le domaine de la prise en charge des personnes en situation du Handicap (ergothérapie, podologie, ...) ;

Mesure 13 : Développer les capacités des professionnels de santé et des autres prestataires dans le domaine de la prise en charge des personnes en situation du Handicap.

Axe 4

Renforcement du cadre réglementaire et partenariat

Objectif : Garantir les droits humains fondamentaux des Personnes en Situation du Handicap en renforçant le cadre législatif et réglementaire

Mesure 14 : Mettre en œuvre les dispositions de la Loi 97-13 relative à la promotion des droits des Personnes en Situation du Handicap ;

Mesure 15 : Créer la synergie et améliorer la collaboration et la coordination en matière du Handicap.

Axe 5

Mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation

Objectif : Lutter contre la stigmatisation, en contribuant au changement des représentations sociales du Handicap.

Mesure 16 : Mettre en place une stratégie de communication sociale par type du Handicap.

Mesure 17 : Promouvoir la création et le soutien des initiatives des associations des personnes en situation du Handicap et de leurs familles.

Axe 6

Suivi-évaluation et recherche

Objectif : Disposer de données fiables quantitatives et qualitatives sur le Handicap.

Mesure 18 : Développer la recherche dans le domaine du Handicap ;

Mesure 19 : Mettre en place un système de suivi et d'évaluation du plan ;

Mesure 20 : Mettre en place un système d'information relatif au Handicap.

Q36: selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la commission nationale de l'offre de soins est assurée par:

- A.** L'inspection générale
- B.** La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires
- C.** La direction de la réglementation et du contentieux
- D.** Le secrétariat général.

Q36: selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la commission nationale de l'offre de soins est assurée par:

- A. L'inspection générale
- B. La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires
- C. La direction de la réglementation et du contentieux
- D. Le secrétariat général.

Q37: la commission régionale de l'offre de soins :

- A. Est présidée par le directeur régional de la santé de la région concernée ou son représentant
- B. Est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant
- C. Est présidée par le président du conseil de la région de la région concernée ou son représentant
- D. Son secrétariat est assurée par la direction régionale de la santé de la région concernée

Q37: la commission régionale de l'offre de soins :

- A. Est présidée par le directeur régional de la santé de la région concernée ou son représentant
- B. Est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant
- C. Est présidée par le président du conseil de la région de la région concernée ou son représentant
- D. Son secrétariat est assurée par la direction régionale de la santé de la région concernée

Q38: selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins:

- A. Sont établis par les directions régionales de la santé concernées
- B. Sont établis pour une période de trois ans
- C. Sont approuvés par des arrêtés du ministre de la santé
- D. Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité

Q38: selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins:

- A. Sont établis par les directions régionales de la santé concernées
- B. Sont établis pour une période de trois ans
- C. Sont approuvés par des arrêtés du ministre de la santé
- D. Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité

Q39: selon le décret de la carte sanitaire, la carte sanitaire:

- A. Est établie pour une période de dix ans
- B. Doit être évaluée tous les cinq ans
- C. Est établie par arrêté du ministre de la santé
- D. Doit être évaluée tous les trois ans

**Q39: selon le décret de la carte sanitaire,
la carte sanitaire:**

- A. Est établie pour une période de dix ans
- B. Doit être évaluée tous les cinq ans
- C. Est établie par arrêté du ministre de la santé
- D. Doit être évaluée tous les trois ans

Q40: les fonctions de soins d'urgence médicales sont:

- A. Au nombre de 14 fonctions
- B. Au nombre de 15 fonctions
- C. Au nombre de 16 fonctions
- D. Au nombre de 17 fonctions

Q40: les fonctions de soins d'urgence médicales sont:

A. Au nombre de 14 fonctions

B. Au nombre de 15 fonctions

C. Au nombre de 16 fonctions

www.ispits.net

D. Au nombre de 17 fonctions

Q41: les principaux axes du plan national pour la prise en charge des urgences médicales sont:

- A.** Amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières
- B.** La réorganisation et la restructuration de la prise en charge des urgences médicales hospitalières
- C.** Renforcement du partenariat public-privé et public-public
- D.** Tous les réponses sont justes

Q41: les principaux axes du plan national pour la prise en charge des urgences médicales sont:

- A. Amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières
- B. La réorganisation et la restructuration de la prise en charge des urgences médicales hospitalières
- C. Renforcement du partenariat public-privé et public-public
- D. Tous les réponses sont justes

Q42: parmi les services d'information et d'orientation aux citoyens:

A. ALLO SAMU 121

B. ALLO surveillance épidémiologique

C. ALLO intoxication

D. Sihati

Q42: parmi les services d'information et d'orientation aux citoyens:

A. ALLO SAMU 121

B. ALLO surveillance épidémiologique

C. ALLO intoxication

D. Sihati

Nouveau programme « KHADAMATI »

Offre de services d'information et d'orientation
aux citoyens via téléphone et internet

 **Âllo Intoxication**
080 100 01 80



 **Âllo surveillance**
épidémiologique
080 100 47 47



 **Âllo SAMU 141**



Âllo chikaya
080 100 53 53



Âllo Mawiidi
(N° de téléphone selon l'Hôpital)
www.mawiidi.ma



Sehati

www.sehati.gov.ma



Santé des jeunes

www.santejeunes.ma



Réseaux de communication sociale du Ministère
de la Santé :



Facebook



Twitter



Youtube



LinkedIn

**Q43: les facteurs de risque reconnus par l'OMS
comme responsables des maladies chroniques
mortelles et handicapantes sont:**

- A.** La consommation du tabac
- B.** L'usage nocif de l'alcool
- C.** L'alimentation malsaine
- D.** Le manque d'activité physique et la sédentarité

**Q43: les facteurs de risque reconnus par l'OMS
comme responsables des maladies chroniques
mortelles et handicapantes sont:**

A. La consommation du tabac

B. L'usage nocif de l'alcool

C. L'alimentation malsaine

D. Le manque d'activité physique et la sédentarité

Campagne nationale de promotion des modes de vie sains :

Le Ministère de la Santé organise, du 18 Avril au 16 Mai 2016, la 1ère campagne nationale de promotion des modes de vie sains, sous le thème « Choisissez le meilleur pour votre santé ». Elle vise à sensibiliser la population marocaine sur les comportements sains à adopter pour lutter contre les facteurs de risque évitables des principales maladies chroniques notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale chronique et les cancers.

Trois facteurs de risque reconnus par l'Organisation Mondiale de la Santé comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes. Les principaux facteurs de risques sont :

- La consommation de tabac
- Le manque d'activité physique et la sédentarité,
- L'alimentation malsaine.

Les messages éducationnels de la campagne se résument autour de l'adoption des 03 comportements sains suivants :

- Une alimentation saine qui repose sur l'équilibre, la variété et la modération , en se basant sur l'héritage culinaire marocain, riche en produits alimentaires naturels et sur la répartition équilibrée des repas et les modes de cuisson préservant les qualités nutritionnelles des repas et réduisant la consommation de sel, de sucre et de gras ;
- La pratique d'une activité physique régulière et non contraignante, d'au moins 30 min par jour, regroupées ou réparties dans la journée ;
- L'éviction du tabagisme, et la sensibilisation de la population générale et en particulier les adolescents et les jeunes sur les dangers de la première cigarette, source d'addictions.

Une large campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation à la santé est prévue à l'échelle nationale. Les messages de la campagne sont relayés sur les médias audiovisuels, par la diffusion de 03 spots en arabe et en amazigh, sur les stations publiques de télévision et de radio, sur les panneaux urbains couvrant les grands axes des grandes villes, un affichage au niveau des établissements de santé, des établissements scolaires et de plusieurs espaces publics.

Les 03 slogans choisis pour la campagne se déclinent selon les 3 thématiques

Q44: le dépistage sélectif du diabète dans les établissements de soins de santé primaires se fait au profit de:

- A.** Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA
- B.** Femmes avec antécédents de diabète gestationnel
- C.** Personnes avec hyperthyroïdie
- D.** Personnes âgées de plus de 45 ans

Population cible

- Il s'agit d'un dépistage sélectif au profit de Personnes à haut risque :
 - Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA ;
 - Femmes avec antécédents de diabète gestationnel ;
 - Femmes ayant accouché d'un enfant avec un poids de naissance élevé (4kg) ;
 - Personnes ayant des antécédents familiaux de diabète de 1^{er} degré ;
 - Personnes avec dyslipidémie ;
 - Personnes âgées de plus de 45 ans.
- Réf: fiche technique: **Lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du diabète :**

Q44: le dépistage sélectif du diabète dans les établissements de soins de santé primaires se fait au profit de:

- A. Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA**
- B. Femmes avec antécédents de diabète gestationnel**
- C. Personnes avec hyperthyroïdie**
- D. Personnes âgées de plus de 45 ans**

**Q45: dans le programme de lutte antituberculeuse
la définition de cas se classe selon:**

A.Le site anatomique

B.La résistance aux médicaments

C.Le statut par rapport au VIH

D.L'antécédent de traitement anti bacillaire

**Q45: dans le programme de lutte antituberculeuse
la définition de cas se classe selon:**

A. Le site anatomique

B. La résistance aux médicaments

C. Le statut par rapport au VIH

D. L'antécédent de traitement anti bacillaire

Réf: Définitions et cadre de notification pour la tuberculose

Révision 2013 (Mise à jour décembre 2014) OMS

Q46: la direction régionale de la santé est composée de:

A. Service de ressources humaines et contentieux

www.ispits.net

B. Service des ressources financières

C. Unité d'approvisionnement

D. Unité de formation et de communication

Q46: la direction régionale de la santé est composée de:

- A.** Service de ressources humaines et contentieux
- B.** Service des ressources financières
- C.** Unité d'approvisionnement
- D.** Unité de formation et de communication

Q47: le territoire de santé est constitué de:

- A. La délégation sanitaire
- B. La circonscription sanitaire
- C. Le centre hospitalier universitaire
- D. Le territoire de santé inter régional

Q47: le territoire de santé est constitué de:

A. La délégation sanitaire

B. La circonscription sanitaire

C. Le centre hospitalier universitaire

D. Le territoire de santé inter régional

Q48: lequel des établissements de santé suivants ne fait pas partie du réseau hospitalier:

- A.** Hôpital psychiatrique
- B.** Centre d'hémodialyse
- C.** Hôpital provincial d'oncologie
- D.** Hôpital régional

Q48: lequel des établissements de santé suivants ne fait pas partie du réseau hospitalier:

A. Hôpital psychiatrique

B. Centre d'hémodialyse

C. Hôpital provincial d'oncologie

D. Hôpital régional

Q49: le réseau hospitalier est appuyé par:

- A.** Centre d'addictologie
- B.** Centre de soins palliatifs
- C.** Centre national de radioprotection
- D.** Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie

Q49: le réseau hospitalier est appuyé par:

A. Centre d'addictologie

B. Centre de soins palliatifs

C. Centre national de radioprotection

D. Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie

Q50: les établissements médico-sociaux publics:

- A. Offrent des prestations de soins sans hébergement
- B. Sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés
- C. font partie du réseau hospitalier
- D. Assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades

Q50: les établissements médico-sociaux publics:

- A. Offrent des prestations de soins sans hébergement
- B. Sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés
- C. font partie du réseau hospitalier
- D. Assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades

Q51: quelque soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau, il dispense les prestations suivantes:

- A.** Le suivi des malades chroniques
- B.** L'assistance de l'accouchement
- C.** La réalisation des examens d'échographie obstétricale
- D.** Les consultations de santé mentale

Q51: quelque soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau, il dispense les prestations suivantes:

- A. Le suivi des malades chroniques**
- B. L'assistance de l'accouchement**
- C. La réalisation des examens d'échographie obstétricale**
- D. Les consultations de santé mentale**

Q52: les fonctions essentielles de santé publique sont au nombre de:

- A.** 4 fonctions
- B.** 6 fonctions
- C.** 8 fonctions
- D.** 9 fonctions

Q52: les fonctions essentielles de santé publique sont au nombre de:

- A. 4 fonctions
- B. 6 fonctions
- C. 8 fonctions
- D. 9 fonctions

Q53: parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie:

- A. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires
- B. Disponibilité des médicaments et biens médicaux
- C. Accessibilité aux soins
- D. Garantie d'un personnel suffisant et compétent

Q53: parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie:

- A. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires**
- B. Disponibilité des médicaments et biens médicaux**
- C. Accessibilité aux soins**
- D. Garantie d'un personnel suffisant et compétent**



- 1. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires**
- 2. Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence**
- 3. Protection de la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail**
- 4. Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de santé**
- 5. Garantir l'efficacité en matière de gouvernance de la santé, une législation de santé publique, un financement et un soutien institutionnel**
- 6. Garantir un personnel suffisant et compétent pour des prestations efficaces en matière de santé publique**
- 7. Communication et mobilisation sociale pour la santé**
- 8. Faire avancer la recherche en santé publique pour avoir une influence sur les politiques et les pratiques**

Q54: en santé publique, on évalue:

- A. La pertinence de l'action
- B. L'impact de l'action
- C. L'accessibilité de l'action
- D. La cohérence de l'action

Q54: en santé publique, on évalue:

- A. La pertinence de l'action
- B. L'impact de l'action
- C. L'accessibilité de l'action
- D. La cohérence de l'action

Q55: selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soin, le droit à la protection de la santé est une:

- A.** Responsabilité des citoyens
- B.** Responsabilité des citoyens et de l'Etat
- C.** Responsabilité de l'Etat et de la société
- D.** Aucune réponse n'est juste

Q55: selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soin, le droit à la protection de la santé est une:

A. Responsabilité des citoyens

B. Responsabilité des citoyens et de l'Etat

C. Responsabilité de l'Etat et de la société

D. Aucune réponse n'est juste

Q56: le livre blanc « pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé » élaboré à l'occasion de la 2ème conférence nationale sur la santé (juillet 2013) a identifié:

- A.** 3 axes et 9 chantiers pour la réforme
- B.** 5 axes et 9 chantiers pour la réforme
- C.** 3 axes et 10 chantiers pour la réforme
- D.** 6 axes et 10 chantiers pour la réforme

Q56: le livre blanc « pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé » élaboré à l'occasion de la 2ème conférence nationale sur la santé (juillet 2013) a identifié:

- A. 3 axes et 9 chantiers pour la réforme**
- B. 5 axes et 9 chantiers pour la réforme**
- C. 3 axes et 10 chantiers pour la réforme**
- D. 6 axes et 10 chantiers pour la réforme**

3 axes et 9 chantiers pour la réforme

- AXE 1 - Agir sur les déterminants de la santé, promouvoir ce qui peut l'améliorer et protéger les populations contre ce qui menace leur santé

- Chantier 1. Développer les «fonctions essentielles de santé publique»
- Chantier 2. Mettre la santé au cœur des politiques publiques: des évaluations d'impact santé pour dialoguer avec les autres secteurs
- Chantier 3. L'action locale sur les déterminants de la santé



3 axes et 9 chantiers pour la réforme

- AXE 2 - Vers la couverture universelle : proximité, qualité, protection financière

- Chantier 4. Une politique de proximité et d'accès
- Chantier 5. Réguler la qualité des soins et protéger les Utilisateurs
- Chantier 6. Réduire la part des paiements directs pour les soins, étendre la couverture des mécanismes de solidarité



3 axes et 9 chantiers pour la réforme

www.ispits.net

- Axe 3. Moderniser la gouvernance de la santé

- Chantier 7. Mettre en place les structures et les capacités que la modernisation de la gouvernance impose de contractualiser la complémentarité public-privé
- Chantier 8. Un système d'information intelligent
- Chantier 9. Un atout qui est aussi un défi : les professionnels de santé et la réforme



Q57: le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants:

- A.**Projet immobilier
- B.**Projet technique
- C.**Projet financier
- D.**Projet médical

4.2 - La structure du PEH

Le PEH définit les axes de développement de l'institution, ainsi que les actions à mettre en place qui devront :

- être réalisables (la faisabilité des actions définies et le pragmatisme doivent guider la démarche),
- en nombre limité,
- inscrites dans un calendrier précis,
- pouvant être évaluées.

Les six volets proposés le plus souvent :

- Le projet médical,
- Le projet de soins,
- Le projet managérial,
- Le projet d'investissement et de maintenance,
- Le projet du système d'information,
- Le projet social.

Référence: Manuel d'élaboration d'un projet d'établissement hospitalier au Maroc

Edition 2016

- Chaque chef de pôle prépare son projet sur la base des informations reçues des départements.

Projet	Responsable
Projet médical	PAM
Projet de soins	PSI
Projet managérial	Directeur
Projet d'investissement et maintenance	Directeur
Projet du système d'information	PAA
Projet social	Directeur

Q57: le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants:

A. Projet immobilier

B. Projet technique

C. Projet financier

D. Projet médical

Q58: selon la portée de la démarche, la planification est:

A. Tactique

B. Pragmatique

C. Populationnelle

D. Opérationnelle

Q58: selon la portée de la démarche, la planification est:

A. Tactique

B. Pragmatique

C. Populationnelle

D. Opérationnelle

Q59: le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes:

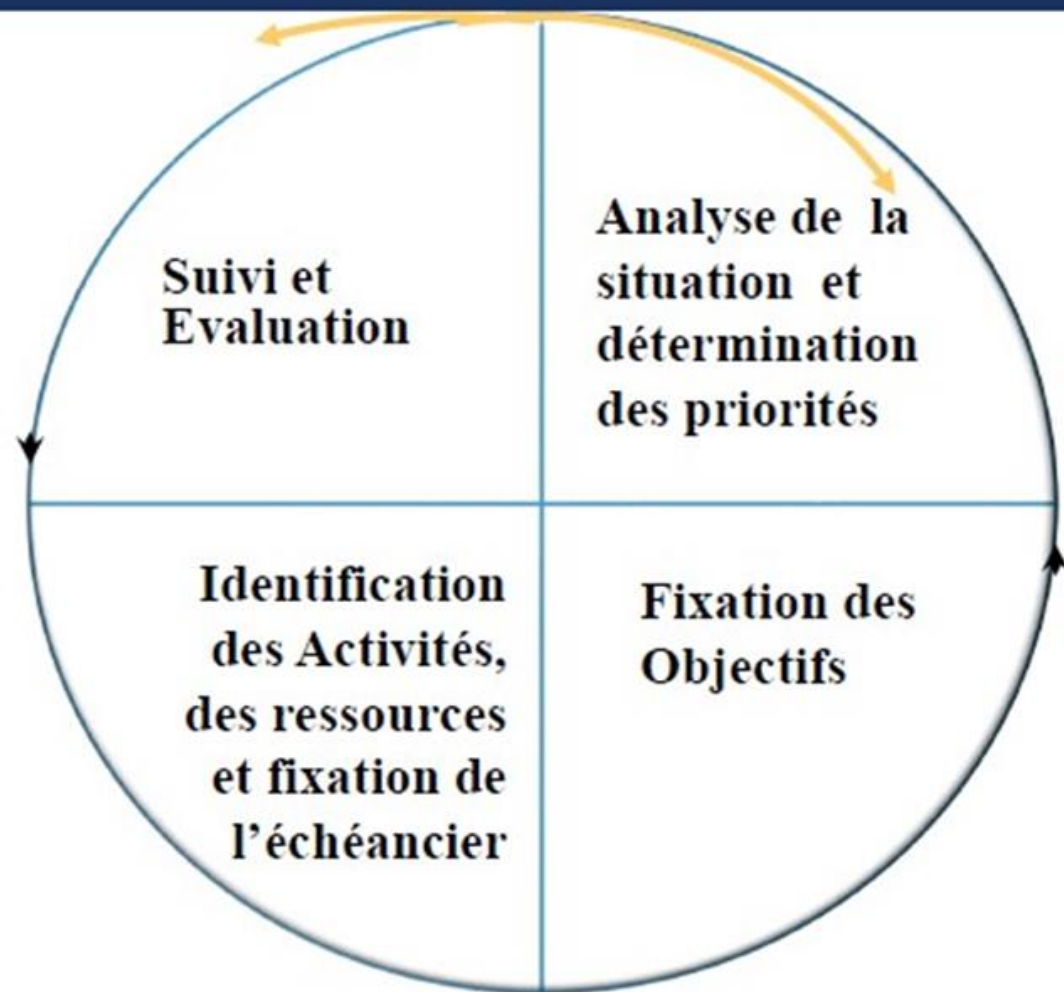
- A.** Analyse de la situation
- B.** Fixation des objectifs
- C.** Détermination des priorités
- D.** Évaluation des ressources

Q59: le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes:

- A. Analyse de la situation
- B. Fixation des objectifs
- C. Détermination des priorités
- D. Évaluation des ressources

LE CYCLE DE LA PLANIFICATION

CANEVAS D'ÉLABORATION D'UN PA

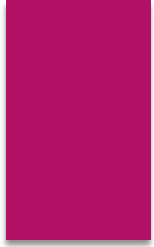


Q60: les caractéristiques de la planification:

- A. Concerne le passé et le futur
- B. Créative
- C. Processus dynamique et continue
- D. Obéit aux orientations stratégiques

Q60: les caractéristiques de la planification:

- A. Concerne le passé et le futur
- B. Créative
- C. Processus dynamique et continue
- D. Obéit aux orientations stratégiques



MERCI POUR VOTRE ATTENTION